

CAHIER DES CHARGES — ONEOBSTRA V1

STATUT

- Version : **V1**
 - Statut : **FIGÉE**
 - Portée : **Cliniques privées**
 - Architecture : **Django server-side**
 - Décision IA : (interdite en V1)
-

CONTEXTE & OBJECTIFS

1.1 Réalité du terrain en clinique privée

- Gynécologues libéraux **souvent absents physiquement**, supervision à distance
- Sage-femme **en première ligne**, seule au lit de la patiente
- Décisions et consignes **échangées oralement ou par WhatsApp**
- Informations **peu structurées, non horodatées, difficilement opposables**
- **Responsabilités floues** en cas de complication
- Prise en charge **post-naissance du nouveau-né insuffisamment intégrée** au dossier de la maman

1.2 Objectifs de OneObstra

- Structurer et sécuriser la **prise en charge obstétricale en clinique privée**
 - Formaliser et tracer les **instructions médicales entre gynécologue et sage-femme**
 - Protéger juridiquement **l'ensemble des acteurs de la prise en charge**
 - Garantir une **traçabilité complète, horodatée et opposable**
 - Assurer une **continuité clinique et médico-légale de la maman au nouveau-né**
-

PÉRIMÈTRE FONCTIONNEL V1

Inclus

- Accouchement
- Supervision à distance
- Instructions gynéco → sage-femme
- Anesthésie (péridurale)
- Post-naissance néonatal immédiat
- Actes ponctuels avec retour domicile
- Audit & conformité

Exclus (volontairement)

- Gynécologues salariés
 - Néonatalogie lourde / long terme
 - IA décisionnelle
 - Planning médical complexe
 - Texte libre clinique critique
-

CONCEPT CENTRAL — PATIENTCASE

Le **PatientCase** est le **cœur absolu de OneObstra V1**.

Il constitue la **référence clinique, organisationnelle et médico-légale unique** pour chaque patiente prise en charge en clinique.

Dans OneObstra, rien n'existe en dehors d'un PatientCase.

3.1 Définition détaillée

PatientCase est le **dossier clinique unique de la maman**, ouvert lors de son arrivée en clinique et maintenu **sans rupture** jusqu'à la clôture de la prise en charge.

Il remplit **simultanément trois rôles** :

Vérité clinique officielle

- Il représente la **réalité clinique opposable** de la prise en charge
- Il fait foi sur :
 - l'état de la patiente
 - les actes réalisés
 - les décisions prises
 - les non-décisions (attente, supervision à distance)

Support de toute la traçabilité

- Tous les actes, décisions, instructions, alertes et silences sont :
 - rattachés au PatientCase
 - horodatés
 - signés par rôle
- Aucune information clinique critique n'est stockée ailleurs (mail, WhatsApp, papier)

Conteneur unique de tous les événements

Le PatientCase contient :

- la **timeline clinique unique**
- les actes de la sage-femme
- les instructions du gynécologue

- les décisions anesthésiques
- la prise en charge post-naissance néonatale
- les analyses médicales
- les décisions de sortie ou de retour à domicile

Un PatientCase = une histoire clinique complète, continue et lisible.

3.2 Création du PatientCase

Qui crée le PatientCase ?

- Le PatientCase est créé **exclusivement par la sage-femme**
- Cette règle est **non négociable en V1**

Quand est-il créé ?

- **À l'arrivée physique de la patiente en clinique**
- Après vérification de l'identité et du contexte d'admission
- Même si la patiente a été orientée ou annoncée à l'avance par un médecin

Qui ne peut PAS le créer ?

- Gynécologue (même référent)
- Anesthésiste
- Pédiatre
- Personnel administratif

Cette règle permet de :

- clarifier la **responsabilité initiale**
 - éviter les dossiers “fantômes”
 - garantir une ouverture **au moment réel de la prise en charge**
-

3.3 Cycle de vie du PatientCase

Le PatientCase suit un **cycle de vie strict, linéaire et tracé** :

ADMISSION
→ TRAVAIL
→ ACCOUCHEMENT
→ POST_NAISSANCE
→ CLOTURE

Chaque état correspond à une **phase clinique identifiable**.

ADMISSION

- Accueil de la patiente

- Vérification identité
 - Motif de venue (accouchement / actes ponctuels)
 - Attribution salle / box
 - Ouverture de la timeline
-

TRAVAIL

- Surveillance clinique
 - Actes sage-femme
 - CTG / monito
 - Touchers vaginaux
 - Instructions gynécologue
 - Décisions implicites ou explicites
-

ACCOUCHEMENT

- Phase expulsive
 - Présence ou arrivée du gynécologue
 - Accouchement voie basse ou intervention
 - Actes anesthésiques éventuels
-

POST_NAISSANCE

- Surveillance maternelle immédiate
- Création automatique du nouveau-né
- Prise en charge néonatale
- Instructions pédiatre
- Analyses médicales du bébé

La post-naissance fait partie intégrante du même PatientCase

Il n'y a pas de rupture maman / bébé en V1

CLOTURE

- Décision de sortie
 - Retour à domicile
 - Fin de la prise en charge
 - Dossier figé en lecture seule
 - Prêt pour export médico-légal
-

3.4 Règles de transition (fondamentales)

Chaque transition du PatientCase :

- est **explicite** (action volontaire, pas automatique)
- est **tracée dans la timeline**
- est **horodatée**
- est **signée par rôle**
- ne peut jamais être supprimée
- ne peut jamais être modifiée a posteriori

Le cycle de vie du PatientCase est **opposable juridiquement**.

3.5 Ce que PatientCase n'est PAS

Pour éviter toute ambiguïté :

- ce n'est pas un simple formulaire
 - ce n'est pas un dossier administratif
 - ce n'est pas un brouillon médical
 - ce n'est pas un dossier créé à distance
 - ce n'est pas un dossier bébé séparé
-

Formulation officielle à intégrer (V1)

Chaque venue physique en clinique donne lieu à un PatientCase distinct. Un PatientCase clôturé ne peut jamais être réutilisé. Un lien d'historique non clinique peut être affiché à titre informatif.

TIMELINE UNIQUE — SOCLE MÉDICO-LÉGAL

La **Timeline** est le **journal officiel des faits** du PatientCase.

C'est la **pièce maîtresse médico-légale** de OneObstra.

Si un élément n'est pas dans la timeline, il est considéré comme n'ayant jamais existé.

4.1 Principe — expliqué simplement

Tout ce qui se passe devient un événement.

Pas seulement :

- ce qui est fait
- mais aussi :
- ce qui est décidé
 - ce qui est attendu

- ce qui n'est pas fait
- ce qui est ignoré
- ce qui est consulté

La timeline raconte **l'histoire complète et objective** de la prise en charge.

Exemple très simple

Situation réelle :

La sage-femme pose un monito, le trouve correct, informe le gynécologue, qui répond "OK, on continue".

Dans OneObstra, cela devient :

1. Événement : *Monito posé*
2. Événement : *Interprétation monito par la sage-femme*
3. Événement : *Information envoyée au gynécologue*
4. Événement : *Décision médicale : poursuite surveillance*

Rien n'est implicite.

Rien n'est "dans la tête".

4.2 Règles de la timeline (fondamentales)

Append-only (jamais modifié, jamais supprimé)

- Un événement :
 - ne se modifie pas
 - ne se supprime pas
- Si une erreur est faite :
 - on **ajoute un nouvel événement correctif**

Principe juridique clé : on n'efface jamais l'histoire, on la complète.

Horodatage système

- Chaque événement est daté :
 - automatiquement
 - par le système
- Impossible de tricher sur l'heure

Cela évite :

- les "reconstitutions après coup"
- les horaires ajustés a posteriori

Signature par rôle (pas par opinion)

Chaque événement indique :

- le **rôle** (sage-femme, gynécologue, anesthésiste, etc.)
- parfois la personne
- jamais un acteur “flou”

On sait toujours **qui a fait quoi**, et **dans quel cadre**.

Visibilité selon RBAC

- Tout le monde **n’écrit pas tout**
- Tout le monde **ne voit pas tout**
- Mais **rien n’est caché au système**

Exemple :

- la sage-femme voit tout le dossier clinique
 - le gynécologue voit la supervision
 - l’audit voit tout, en lecture seule
-

Lisible tribunal

La timeline est conçue pour être :

- chronologique
- compréhensible
- exportable
- lisible par un non-clinicien

Un juge doit pouvoir comprendre **sans interprétation médicale**.

4.3 Types d’événements — avec exemples concrets

Actes cliniques

Ce qui est fait concrètement.

Exemples :

- Toucher vaginal réalisé
- Monito (CTG) posé
- Injection effectuée
- Pose péridurale

- Examen post-partum

Chaque acte = 1 événement.

Instructions médicales

Ce qui est demandé par un médecin.

Exemples :

- “Surveiller le travail”
- “Reposer un monito dans 1h”
- “Appeler si dilatation > 6 cm”

L’instruction existe même si elle n’est pas encore exécutée.

Décisions

Choix médicaux explicites.

Exemples :

- Poursuite du travail
- Déclenchement
- Appel du gynécologue
- Passage au bloc
- Retour à domicile

Une décision engage une responsabilité.

Non-décisions

Une **non-décision** correspond à un **choix médical conscient de ne pas engager immédiatement une action**, tout en maintenant une surveillance active et une responsabilité médicale.

Il ne s’agit **ni d’un oubli, ni d’une absence de décision**, mais d’une **décision clinique à part entière**, fondée sur l’évaluation du contexte au moment donné.

Exemples courants

- « On attend »
- « On surveille l’évolution »
- « Pas d’intervention pour l’instant »
- « Réévaluation ultérieure prévue »

Règles ONEOBSTRA (V1)

- Toute non-décision doit être **explicitement tracée** dans la timeline
- Elle est **horodatée** et **associée à un rôle médical**
- Elle précise :

- le **contexte clinique**
- la **durée ou condition de réévaluation**
- Elle engage une **responsabilité médicale claire**

Intérêt médico-légal

Tracer une non-décision permet de :

- démontrer qu'une situation a bien été **évaluée**
- prouver qu'un **choix raisonné** a été fait
- éviter toute interprétation a posteriori d'un « silence » ou d'une « inaction »

Dans ONEOBSTRA, **ne pas agir est un acte médical documenté**, au même titre qu'une intervention.

Silences

Un **silence** correspond à une **absence de réponse ou d'action dans une situation où une réponse était attendue**, compte tenu du contexte clinique, du rôle concerné et des délais définis.

Il ne s'agit **ni d'un oubli supposé, ni d'une interprétation**, mais d'un **fait objectif mesurable dans le temps**.

Exemples courants

- Instruction médicale **émise** sans accusé de réception
- Résultat d'analyse **disponible** sans interprétation médicale
- Alerte clinique **déclenchée** sans réponse dans le délai imparti
- Demande d'information **envoyée** sans retour

Règles ONEOBSTRA (V1)

- Le silence est **détecté automatiquement** à l'expiration d'un délai attendu
- Il est **tracé comme un événement à part entière** dans la timeline
- Il est :
 - **horodaté**
 - associé à un **rôle**
 - lié à l'élément concerné (instruction, analyse, alerte)
- Il peut déclencher une **alerte** ou une **escalade** selon la criticité

Intérêt médico-légal

La traçabilité des silences permet de :

- distinguer clairement une **décision explicite** d'une **absence de réponse**
- éviter les reconstitutions subjectives a posteriori
- protéger les acteurs présents sur le terrain
- établir une **chronologie factuelle incontestable**

Dans ONEOBSTRA, **le silence n'est pas une zone grise** :

c'est un **événement objectif, tracé et opposable**.

Alertes

Une **alerte** correspond au **signalement explicite d'un risque, d'une anomalie ou d'un dépassement** par rapport aux règles cliniques, aux délais attendus ou aux seuils définis.

L'alerte n'est **ni décorative ni facultative** : elle constitue un **événement clinique à part entière**, immédiatement traçable.

Exemples courants

- Toucher vaginal réalisé à une fréquence supérieure à la recommandation
- Instruction médicale non exécutée dans le délai prévu
- Anomalie détectée sur un CTG / monito
- Résultat d'analyse en dehors des seuils définis
- Absence de réponse à une demande clinique critique

Règles ONEOBSTRA (V1)

- Toute alerte est **automatiquement tracée** dans la timeline
- Elle est :
 - **horodatée**
 - associée à un **rôle**
 - liée à l'événement déclencheur
- Elle reste **visible**, même si elle est ignorée ou non traitée
- Elle peut entraîner :
 - une **escalade automatique**
 - une **notification ciblée** selon la gravité

Intérêt clinique et médico-légal

Tracer les alertes permet de :

- signaler précocement les situations à risque
- garantir que l'information critique a bien été émise
- distinguer l'alerte de la réponse (ou de l'absence de réponse)
- fournir une **chronologie factuelle opposable**

Dans ONEOBSTRA, **une alerte existe indépendamment de sa prise en charge** :

elle est **documentée, traçable et juridiquement opposable**.

Analyses médicales — Distinction mère / nouveau-né & gestion des images (V1)

Distinction stricte mère / nouveau-né

ONEOBSTRA distingue **explicitement** :

- les **analyses concernant la mère**
- les **analyses concernant le nouveau-né**

Chaque analyse est :

- rattachée **soit à la maman**, soit au **nouveau-né**
- intégrée dans la **timeline unique**, avec une identification claire de la cible clinique
- visible dans la continuité **mère** → **bébé**, sans confusion possible

Cette distinction est **obligatoire**, tant sur le plan clinique que médico-légal.

Gestion des résultats sous forme d'images

Les résultats d'analyses peuvent être **stockés sous forme d'images**, notamment pour :

- résultats biologiques externes
- documents scannés
- exports d'appareils
- **tracés CTG / monito**
- impressions papier photographiées

Types d'images concernées

- **CTG / monito maternel**
 - Résultats biologiques (glycémie, gaz du sang, etc.)
 - Données néonatales (saturation, température, bilans)
-

Règles de stockage des images (V1)

Chaque image :

- est **enregistrée comme pièce brute**
- est **horodatée automatiquement**
- est liée à :
 - une **prescription médicale**
 - un **PatientCase**
 - une **cible clinique** (mère ou nouveau-né)
- est **non modifiable**
- constitue une **preuve factuelle**

L'image est intégrée à la timeline comme :

Résultat d'analyse — support image

Interprétation médicale obligatoire (rappel)

Une image n'est jamais suffisante seule.

Après dépôt de l'image :

- un médecin habilité (gynécologue, réanimateur, pédiatre) doit :
 - consulter l'image
 - formuler une **interprétation médicale explicite**
 - prendre une **décision clinique associée**

Image sans interprétation → alerte automatique

Silence après image → silence médical tracé

Cas spécifique — CTG / Monito

Pour les tracés CTG / monito :

- l'image du tracé est conservée comme **preuve originale**
 - l'interprétation initiale est **structurée** (rythme de base, variabilité, décélérations, conclusion)
 - l'interprétation engage la **responsabilité médicale**
 - toute réinterprétation ultérieure est **tracée comme nouvel événement**
-

Disponibilité permanente à la consultation

Les images (analyses, CTG, monito) sont :

- **consultables à tout moment**
- accessibles selon les droits RBAC
- visibles :
 - en contexte clinique (prise en charge en cours)
 - en supervision
 - en **vue tribunal**
- conservées sans limitation pendant la durée légale

Aucune image critique n'est archivée hors du dossier actif.

Intérêt clinique et médico-légal

Ce modèle garantit :

- une séparation claire entre :
 - **donnée mesurée** (image)
 - **raisonnement médical** (interprétation)
- une preuve brute **inaltérable**
- une lecture chronologique **opposable**

- une continuité parfaite **mère** → **bébé**

Dans ONEOBSTRA :

- **l'image est le fait**
 - **l'interprétation est l'acte**
 - **la décision est la responsabilité**
-

Accès & exports

Les **accès et exports** permettent de tracer précisément **qui a consulté quelles informations, à quel moment et à quelle fin**.

Il s'agit d'un **socle essentiel de preuve**, indispensable à la sécurité médico-légale.

Exemples d'événements tracés

- Consultation d'un PatientCase
- Consultation d'une section spécifique (timeline, CTG, analyses)
- Export de documents (PDF clinique, PDF tribunal)
- Impression de documents
- Téléchargement de pièces (images, résultats)

Règles ONEOBSTRA (V1)

- Tout accès est :
 - **automatiquement tracé**
 - **horodaté**
 - associé à un **utilisateur et un rôle**
 - lié au **PatientCase concerné**
- Tout export ou impression :
 - génère un **événement distinct**
 - précise le **type de document**
 - est conservé dans le journal d'audit
- Aucune consultation critique n'est anonyme

Intérêt médico-légal

La traçabilité des accès et exports permet de :

- reconstituer précisément les consultations du dossier
- démontrer la confidentialité et le respect des droits d'accès
- identifier les usages en cas de litige
- fournir une **preuve opposable** en cas de contentieux ou d'audit

Dans ONEOBSTRA, **consulter est un acte traçable**,

exporter ou imprimer est un fait opposable.

Exemple complet “banalisé”

Situation réelle :

Patiente en travail, monito correct, gynécologue à distance, accouchement plus tard sans complication.

Timeline OneObstra :

- Admission patiente
- Monito posé
- Interprétation monito SF : normal
- Information envoyée gynécologue
- Décision : poursuite surveillance
- Travail actif
- Appel gynécologue
- Accouchement
- Création nouveau-né
- Surveillance post-naissance
- Sortie

Tout est clair.

Tout est opposable.

Conclusion clé

La timeline n’est pas un historique technique. C’est un outil de protection clinique et juridique.

Elle permet de répondre sans ambiguïté à :

- Qui a fait quoi ?
 - Quand ?
 - Sur quelle base ?
 - Avec quelle information disponible ?
-

ACTEURS & RÔLES — ONEOBSTRA

V1

ONEOBSTRA V1 repose sur une **définition stricte, réaliste et juridiquement sûre des acteurs**, alignée avec la pratique des cliniques privées.

L’objectif est clair :

savoir qui fait quoi, quand, sous quelle responsabilité, et avec quelle traçabilité.

Principes fondamentaux (V1 — non négociables)

- Un acteur est **une personne réelle** (profil professionnel)
- Chaque acteur a :
 - une **profession principale** (identité légale)
 - une ou plusieurs **fonctions exercées** (contextuelles)
- Le **rôle actif est automatiquement déduit** de la fonction
- Aucun acteur ne choisit manuellement son rôle
- Toute prise de fonction, changement ou fin de fonction est :
 - horodatée
 - tracée
 - opposable

Profession = identité

Fonction = contexte d'exercice

Rôle = droits effectifs à l'instant T (automatique)

Sage-femme (salariée de la clinique)

Rôle central de ONEOBSTRA

La sage-femme est **le point d'entrée du système** et l'actrice principale sur le terrain.

Responsabilités (V1)

- Création **exclusive** du PatientCase
- Admission de la patiente
- Surveillance clinique continue
- Réalisation des actes de sage-femme
- Pose du CTG / monito
- **Interprétation initiale structurée du CTG**
- Toucher vaginal (règle des 4 h, dérogations tracées)
- Coup de sonde (aide clinique non diagnostique)
- Exécution des instructions médicales
- Déclenchement d'alertes / appel médecins
- Décision de retour à domicile (actes ponctuels)
- Surveillance post-partum immédiate (2 h)
- Coordination avec :
 - infirmier·e
 - néonatal
 - médecins
- Organisation des relais (changement de sage-femme)

Interdictions

- Pas de prescription médicale
 - Pas de diagnostic médical
-

Gynécologue libéral / externe

Supervision médicale obstétricale

Le gynécologue est le **responsable médical de la patiente**, souvent à distance, présent physiquement au moment opportun.

Responsabilités

- Orientation de la patiente vers la clinique
- Don d'**instructions médicales structurées** à la sage-femme
- Supervision à distance du travail
- Prise de **décisions médicales**
- Présence physique au moment opportun (accouchement, complication)
- Prescription :
 - analyses médicales (mère)
 - examens d'imagerie (radio, scanner, IRM, échographie médicale)
- Validation de décisions clés

Interdictions (V1)

- Ne crée **jamais** le PatientCase
 - Pas de statut salarié dans ONEOBSTRA
 - Pas de gestion RH gynécologue
-

Anesthésiste

Sécurité anesthésique

Responsabilités (V1)

- Demande et validation de la **pré-anesthésie**
- Vérification du **consentement**
- Choix de la technique anesthésique :
 - péridurale
 - rachianesthésie
 - anesthésie générale
- Réalisation de l'anesthésie
- Surveillance post-anesthésique
- Gestion des incidents anesthésiques

- Prescription d'examens si nécessaire
-

Infirmier·e anesthésiste (IADE)

Exécution anesthésique spécialisée

- Intervention **avant ou après la naissance**
- Uniquement :
 - au bloc opératoire
 - ou en réanimation
- **Sur décision médicale**
- Sous responsabilité directe de l'anesthésiste

Responsabilités (V1)

- Assistance anesthésique
- Actes délégués
- Surveillance anesthésique
- Traçabilité des paramètres

Aucune décision médicale

Aucune prescription

Infirmier·e de bloc opératoire

Assistance opératoire

- Intervention **avant ou après la naissance**
- Exclusivement au **bloc opératoire**
- Sur décision médicale

Responsabilités (V1)

- Préparation du bloc
 - Assistance opératoire
 - Gestion du matériel
 - Check-lists de sécurité
 - Traçabilité opératoire
-

Infirmier·e de réanimation

Soins critiques

- Intervention **avant ou après la naissance**

- En situation critique
- Sur décision médicale

Responsabilités (V1)

- Soins prescrits
 - Surveillance rapprochée
 - Monitoring continu
 - Alerte immédiate
-

Infirmier·e d'hôpital de jour

Actes programmés sans hospitalisation

- Avant ou après naissance
- Sur prescription médicale

Responsabilités (V1)

- Réalisation d'actes programmés :
 - injections
 - perfusions
 - prélèvements
 - monito
- Surveillance courte
- Traçabilité des actes

Ne crée pas de PatientCase

Ne décide pas

Infirmier·e néonate

Soins du nouveau-né

- Intervention **après la naissance**
- Dans la **section néonatale du PatientCase**

Responsabilités (V1)

- Soins infirmiers néonataux
 - Surveillance du nouveau-né
 - Réalisation des analyses prescrites
 - Demandes d'avis au pédiatre
 - Alerte en cas d'anomalie
-

Pédiatre

Référent médical du nouveau-né

Responsabilités (V1)

- Instructions médicales néonatales
- Prescription et **interprétation obligatoire** des analyses
- Décisions médicales concernant le bébé

Pas de dossier bébé séparé en V1

Tout est dans le PatientCase de la mère

Administrateur clinique

Organisation & sécurité

Responsabilités (V1)

- Paramétrage de la clinique
- Gestion des profils et fonctions
- Autorisations par rôle
- Seuils, règles, protocoles
- Accès audit & vue tribunal

Aucun acte clinique

Aucune décision médicale

Règle clé — Fonction $\Rightarrow$ rôle automatique (V1)

Tout changement de fonction entraîne automatiquement un changement de rôle actif.

Aucun rôle n'est choisi manuellement.

Toute transition est tracée et opposable.

Synthèse finale

Acteur	Présence	Nature
Sage-femme	Sur place	Pilotage clinique
Gynécologue libéral	Distance / ponctuelle	Décision
Anesthésiste	Ciblée	Anesthésie
IADE	Bloc / réanimation	Exécution

Acteur	Présence	Nature
Infirmier bloc	Bloc	Assistance
Infirmier réa	Réanimation	Soins critiques
Infirmier hôpital de jour	Programmé	Actes courts
Infirmier néonate	Post-naissance	Soins bébé
Pédiatre	Supervision	Décision bébé
Admin clinique	Hors clinique	Paramétrage

ORIENTATION DE LA PATIENTE (MÉDECIN)

L'**orientation** permet à un médecin (gynécologue ou autre médecin prescripteur) de **préparer la venue éventuelle d'une patiente en clinique, sans jamais créer de dossier clinique** ni programmer d'acte obstétrical à l'avance.

L'orientation exprime une **intention médicale**,

la **prise en charge clinique commence uniquement à l'arrivée physique de la patiente**.

6.1 Principe

Un médecin peut **orienter** une patiente vers la clinique afin de :

- signaler une venue probable,
- transmettre un contexte médical utile,
- formuler des consignes initiales.

L'orientation ne vaut ni admission, ni prise en charge clinique.

6.2 Contenu de l'orientation

Chaque orientation est **structurée, tracée et horodatée**, et contient uniquement des informations préparatoires.

Motif de l'orientation

Le motif décrit **la raison immédiate** pour laquelle la patiente est envoyée à la clinique **pour évaluation ou surveillance, sans programmation d'acte lourd**.

Motifs autorisés en V1

- Surveillance du travail
- Monito / CTG
- Douleurs ou contractions
- Suspicion d'anomalie clinique
- Diminution des mouvements fœtaux
- Contrôle après consultation
- Évaluation avant décision médicale

- Actes ponctuels (injection, prélèvement, surveillance courte)
-

ENCadré — INTERDIT V1 : Programmation obstétricale lourde

En ONEOBSTRA V1, il est strictement interdit d'utiliser l'orientation pour :

- un **déclenchement programmé**
- une **césarienne programmée**
- toute **intervention obstétricale planifiée à l'avance**

L'orientation V1 sert uniquement à organiser une venue pour évaluation ou prise en charge non programmée.

Toute décision d'intervention lourde :

- est prise **après l'arrivée physique de la patiente**
- repose sur l'évaluation clinique réelle
- est **tracée dans la timeline**

La programmation obstétricale relève **exclusivement d'une version ultérieure (V2)**.

Niveau d'urgence

Le médecin précise le degré d'urgence de la venue :

- **Standard** : venue dans la journée
- **Urgent** : venue rapide souhaitée
- **Immédiat** : venue sans délai

Ce niveau est **indicatif** et n'engage aucune action clinique avant l'arrivée réelle.

Consignes initiales

Le médecin peut transmettre des consignes préparatoires, par exemple :

- « faire un monito »
- « surveiller pendant 1 heure »
- « m'appeler si anomalie »
- « évaluer avant décision »

Ces consignes sont :

- tracées,
 - structurées,
 - **sans effet clinique** tant que la patiente n'est pas arrivée.
-

Date / créneau souhaités (non contraignants)

Le médecin peut indiquer une date ou un créneau horaire souhaité :

- information **indicative uniquement**
- non opposable
- comparée systématiquement à l'arrivée réelle

L'écart entre souhait et réalité est **conservé et traçable**.

Objectif de l'orientation (V1 clarifié)

Le médecin précise **l'intention générale** de la venue, **sans jamais programmer un acte obstétrical lourd**.

Prise en charge obstétricale non programmée

- Patiente envoyée pour :
 - surveillance du travail
 - évolution possible vers un accouchement
- **Aucun déclenchement ni césarienne n'est planifié**
- Toute décision d'intervention :
 - est prise **après l'arrivée réelle**
 - repose sur l'évaluation clinique
 - est tracée dans la timeline

L'accouchement peut avoir lieu,

mais **il n'est jamais programmé via l'orientation**.

Actes ponctuels + retour domicile

- Patiente envoyée pour :
 - monito / CTG
 - injection
 - surveillance courte
 - **Aucune intention d'accouchement**
 - Retour à domicile si la situation est stable
-

6.3 Règles fondamentales (NON NÉGOCIABLES)

- Le médecin **ne crée jamais** le PatientCase
- Aucune responsabilité clinique n'existe avant l'arrivée réelle
- La sage-femme :
 - accueille physiquement la patiente
 - vérifie l'identité
 - évalue la situation réelle

- décide de l'ouverture du PatientCase
 - La responsabilité clinique commence **uniquement à l'arrivée physique**
-

6.4 Cas particulier — Patiente non présentée

- Sans arrivée physique :
 - aucun PatientCase
 - aucun acte clinique
 - Après dépassement du délai paramétré :
 - l'orientation est clôturée avec le statut
« **Patiente non présentée** »
 - Tous les éléments restent auditables (orientation, délai, clôture)
-

Synthèse clé à retenir

L'orientation prépare la venue. La sage-femme ouvre le dossier. La responsabilité clinique commence uniquement à l'arrivée réelle de la patiente.

TYPES DE FEMMES PRISES EN CHARGE — RÉFÉRENCE OFFICIELLE V1

Dans ONEOBSTRA V1, le **type de femme** décrit le **contexte réel de la prise en charge**, pas un jugement ni un diagnostic.

Il est :

- **sélectionné à l'admission** (de façon prudente),
- **visible partout** (en-tête, timeline, exports),
- **évolutif uniquement après faits cliniques tracés**.

Un **seul PatientCase**, quel que soit le type ou son évolution.

Femme suivie

Définition

Patiente suivie régulièrement par un gynécologue libéral identifié.

Quand l'utiliser

- arrivée spontanée
- ou arrivée après orientation simple

- suivi connu et continu

Exemple

Mme A., suivie par Dr X, arrive avec contractions régulières.

Dans OneObstra

- type sélectionné à l'admission
 - supervision médicale claire
 - évolution possible vers accouchement
-

Femme envoyée (anticipée / urgente)

Définition

Patiente adressée par un médecin pour une venue ciblée.

Quand l'utiliser

- monito demandé
- douleur à évaluer
- urgence relative ou immédiate

Exemple

“J’envoie Mme B. pour un CTG aujourd’hui.”

Dans OneObstra

- orientation tracée
 - type sélectionné à l'admission
 - peut évoluer (fausse alerte, accouchement...)
-

Femme sans gynécologue

Définition

Patiente se présentant **sans gynécologue référent connu**.

Quand l'utiliser

- suivi interrompu
- déménagement
- urgence imprévue

Exemple

Mme C. arrive en travail sans suivi récent.

Dans OneObstra (règle V1)

- triage par sage-femme

- affectation automatique d'un gynécologue
 - traçabilité renforcée
-

Femme transférée

Définition

Patiente transférée depuis une autre structure.

Quand l'utiliser

- transfert hôpital → clinique
- autre clinique → votre clinique

Exemple

Mme D. transférée pour poursuite du travail.

Dans OneObstra

- PatientCase créé à l'arrivée
 - responsabilité clinique à partir du transfert effectif
 - contexte du transfert tracé
-

Femme programmée (V1 — clarification importante)

Définition V1

Venue **anticipée, sans programmation d'acte obstétrical lourd.**

Interdit V1 :

- déclenchement programmé
- césarienne programmée

Exemples autorisés V1

- contrôle à terme
- surveillance planifiée
- évaluation pré-accouchement

Exemple

Mme E. vient pour surveillance à J+1 du terme.

Femme à risque obstétrical

Définition

Patiente avec facteur(s) de risque connu(s).

Exemples

- diabète gestationnel
- HTA
- antécédents obstétricaux

Dans OneObstra

- risque visible
 - alertes adaptées
 - décisions médicales renforcées
-

Grossesse particulière

Définition

Grossesse sortant du cadre standard.

Exemples

- grossesse multiple
- post-terme
- présentation particulière

Dans OneObstra

- contexte clairement affiché
 - vigilance accrue
 - continuité dans le même PatientCase
-

Arrivée hors scénario

Définition

Patiente arrivant **différemment de ce qui était attendu.**

Exemples

- sans orientation
- hors créneau souhaité
- contexte plus grave que prévu

Dans OneObstra

- la réalité prime
 - écart tracé
 - type ajustable après évaluation
-

Fausse alerte (après examen uniquement)

Définition

Conclusion clinique **après évaluation documentée.**

Quand l'utiliser

- monito normal
- pas de travail actif
- décision de retour domicile

Jamais à l'admission

Exemple

Contractions ressenties, CTG normal → retour domicile → fausse alerte.

Accouchement imminent / inopiné

Définition

Patiente arrivant en phase très avancée de travail.

Exemples

- dilatation complète
- urgence immédiate

Dans OneObstra

- PatientCase créé immédiatement
 - traçabilité maximale
 - décisions rapides mais documentées
-

Situation sociale particulière

Définition

Contexte non médical impactant la prise en charge.

Exemples

- isolement social
- précarité
- barrière linguistique

Dans OneObstra

- information visible
 - intégrée à la vigilance globale
 - sans jugement
-

Souhaits spécifiques

Définition

Souhaits exprimés par la patiente.

Exemples

- projet de naissance
- refus d'un acte
- préférences particulières

Dans OneObstra

- souhaits tracés
 - respectés si compatibles
 - justification tracée si dérogation
-

Réorientation

Définition

Décision de ne pas poursuivre la prise en charge dans la clinique.

Exemples

- transfert vers hôpital
- niveau de risque incompatible

Dans OneObstra

- décision explicite
 - motif documenté
 - fin claire de responsabilité
-

Actes ponctuels + retour domicile

Définition

Venue pour actes ciblés **sans intention d'accouchement**.

Exemples

- monito isolé
- injection
- surveillance courte

Dans OneObstra

- PatientCase créé à l'arrivée
 - actes tracés
 - évaluation finale
 - retour domicile documenté
-

Règles transversales (V1)

- Le type est **obligatoire à l'admission**

- Il peut **évoluer uniquement** après faits cliniques tracés
 - Tout changement = **événement timeline**
 - Le type donne le **contexte**, pas la décision
-

Phrase clé à retenir

Le type de femme décrit le contexte réel de la prise en charge, évolue avec les faits cliniques, et protège juridiquement tous les acteurs.

SAGE-FEMME — RÔLE CENTRAL (V1 FINAL)

Dans **ONEOBSTRA V1**, la **sage-femme** est le pivot absolu de la prise en charge clinique.

- Elle est **la seule professionnelle présente en continu** auprès de la patiente
- Elle **réalise l'admission** et ouvre le **PatientCase**
- Elle est **automatiquement la sage-femme responsable**
- Elle **observe, agit, alerte**
- Elle **trace chaque fait clinique**
- Elle est **protégée par la traçabilité opposable** du système

Sans action de la sage-femme, aucun fait clinique n'existe dans ONEOBSTRA.

RÈGLE FONDAMENTALE V1 — RESPONSABILITÉ

La sage-femme qui réalise l'admission est automatiquement responsable de la patiente.

Il n'existe aucun acte séparé de "prise en charge".

La responsabilité est **automatique, horodatée et opposable**, jusqu'à un relais explicite ou la clôture du PatientCase.

Paramétrable (Admin clinique)

- types de relais autorisés
 - rôles autorisés à initier un relais
 - règles de validation du relais
-

8.1 UX SAGE-FEMME — PRINCIPES NON NÉGOCIABLES

L'interface sage-femme est conçue pour le **stress réel du terrain**.

Principes UX

- **Écran unique**
- **En-tête fixe (toujours visible)**
 - identité patiente
 - type de femme
 - âge gestationnel
 - sage-femme responsable
 - gynécologue référent
 - état du travail
- **Boutons = actes cliniques**
- **1 clic = 1 événement**
- **Zéro saisie clavier critique**
- **Justification obligatoire en cas de dérogation**

L'UX guide, contraint et protège juridiquement.

Paramétrable (Admin clinique)

- affichage de certains champs non critiques
 - seuils d'alertes visuelles (couleurs, badges)
 - terminologie locale (ex : "travail actif")
-

8.2 ACTES DE LA SAGE-FEMME (V1)

Règle générale

Chaque acte :

- correspond à un **geste clinique réel**
- est **déclenché explicitement**
- crée un **événement timeline horodaté et signé**
- engage une responsabilité **claire et bornée**

Paramétrable (Admin clinique)

- catalogue des actes activés
 - ordre d'affichage des actes
 - seuils de rappel / alerte par acte
-

Admission — ACTE FONDATEUR (V1)

Quand ?

À l'arrivée **physique réelle** de la patiente.

Actions

- vérification de l'identité

- création du **PatientCase**
- sélection du **type de femme**
- renseignement du **contexte d'arrivée**

La sage-femme devient **automatiquement responsable**.

Paramétrable (Admin clinique)

- liste des types de femmes
 - valeurs possibles du contexte d'arrivée
 - champs administratifs affichés
-

Acte — Constantes cliniques maternelles

Acte clinique réitérable, réalisé autant de fois que nécessaire

Constantes initiales (post-admission)

- obligatoires
- définissent le **point zéro clinique opposable**

Constantes de surveillance

- réalisées librement pendant la prise en charge

Données structurées

- tension artérielle
- fréquence cardiaque
- température
- fréquence respiratoire
- saturation O₂
- douleur
- contractions

Paramétrable (Admin clinique)

- liste des constantes actives
 - seuils normaux / anormaux
 - déclenchement d'alertes
 - fréquence recommandée (non bloquante)
-

Acte — Évaluation fœtale

Acte clinique distinct, réitérable

Données

- mouvements fœtaux
- BCF (doppler)

- liquide amniotique
- statut des membranes
- heure de rupture

Paramétrable (Admin clinique)

- champs activés
 - seuils BCF
 - types de liquide proposés
 - obligation ou non selon contexte
-

Surveillance du travail

- observation clinique continue
- adaptation de la vigilance

Paramétrable (Admin clinique)

- niveaux de vigilance disponibles
 - règles d'escalade automatique
 - rappels temporels
-

CTG / Monito

- acte ponctuel ou continu
- interprétation structurée
- photo obligatoire

Paramétrable (Admin clinique)

- types de CTG
 - critères d'interprétation
 - nombre de photos exigées
-

Toucher vaginal — Règle des 4 heures

- acte réitérable
- alerte si < 4 h
- dérogation justifiée

Paramétrable (Admin clinique)

- délai recommandé (ex : 4 h)
 - motifs de dérogation
 - niveaux d'alerte
-

Actes ponctuels

Injection, prélèvement, surveillance courte, etc.

Paramétrable (Admin clinique)

- liste des actes ponctuels autorisés
 - conditions de retour domicile
-

Alerte / appel médecin

- alerte horodatée
- réponse ou silence tracé

Paramétrable (Admin clinique)

- types d'alertes
 - délais de réponse attendus
 - règles d'escalade
-

Décision de retour domicile

- décision explicite
- clôture du PatientCase

Paramétrable (Admin clinique)

- critères affichés
 - validation médicale requise ou non
-

Post-partum immédiat — PHASE CRITIQUE

- **2 heures obligatoires**
- surveillance mère + bébé
- constantes répétées

Paramétrable (Admin clinique)

- durée minimale
 - fréquence des constantes
 - critères de sortie de phase
-

Sécurité matériel — COMPTAGE DES COMPRESSES

- comptage AVANT / APRÈS
- blocage si discordance

Paramétrable (Admin clinique)

- actes soumis au comptage
 - types de matériel suivis
-

RÈGLE TRANSVERSALE V1

Tout acte de la sage-femme est explicite, horodaté, signé et opposable.

Aucun acte n'est implicite.

Aucun silence n'est neutre.

SYNTHÈSE FINALE

- La sage-femme **admet, agit et surveille**
- ONEOBSTRA **structure**
- La timeline **prouve**
- Le système **protège**

La sage-femme est le moteur clinique. ONEOBSTRA est son filet de sécurité médico-légal.

INSTRUCTIONS GYNÉCO → SAGE-FEMME (V1 FINAL)

Dans ONEOBSTRA V1, les **instructions médicales ne sont jamais orales, floues ou implicites.**

Elles sont **structurées, tracées, suivies dans le temps et opposables médico-légalement.**

Une instruction = **un acte médical à part entière.**

9.1 Principe général

Le gynécologue peut transmettre à la sage-femme des **instructions médicales claires et structurées**, telles que :

- surveillance particulière
- réalisation d'un acte
- attente / temporisation
- appel à un moment précis
- conduite à tenir conditionnelle

Aucune instruction critique ne doit passer uniquement par téléphone ou WhatsApp.

ONEOBSTRA devient le **canal officiel.**

9.2 Contenu d'une instruction (STRUCTURÉ — V1)

Chaque instruction contient obligatoirement :

- **Type d'instruction**
 - surveillance
 - acte à réaliser
 - appel ultérieur
 - conduite conditionnelle
- **Priorité**
 - normale
 - urgente
- **Délai attendu**
 - immédiat
 - < 30 min
 - < 1 h
 - personnalisé (paramétrable)
- **Critères cliniques associés**
 - menus / choix normés
- **Destinataire**
 - sage-femme en charge

Pas de texte libre non structuré

Pas de consigne ambiguë

9.3 Cycle de vie d'une instruction (V1)

ÉMISE

→ REÇUE

→ EN COURS

→ RÉALISÉE

RETARD

OBSTACLE

Chaque changement d'état :

- est **explicite**
 - est **horodaté**
 - génère un **événement dans la timeline**
-

ÉMISE

- Instruction créée par le gynécologue

- Visible immédiatement par la sage-femme
 - Horodatage système
-

REÇUE

- La sage-femme accuse réception
 - La responsabilité devient partagée
 - Début du **compte à rebours du délai**
-

EN COURS

- L'instruction est en cours d'exécution
 - Situation connue et suivie
 - Pas encore finalisée
-

RÉALISÉE

- L'instruction a été exécutée
 - Résultat tracé
 - Fermeture normale du cycle
-

RETARD

Instruction non réalisée **dans le délai attendu**, malgré possibilité technique.

- Motif de retard **obligatoire** (menu) :
 - charge de travail
 - priorité concurrente
 - attente évolution clinique
 - Le retard est **documenté**
 - La sage-femme est protégée
-

OBSTACLE

Instruction **impossible à réaliser**.

- Motif obligatoire (menu) :
 - impossibilité clinique
 - patiente indisponible
 - matériel manquant
 - contradiction médicale
 - Le gynécologue est informé
 - Décision médicale requise
-

9.4 Délais & silence médical

Délais paramétrables (V1)

- Paramétrables par :
 - type d'instruction
 - niveau d'urgence
 - clinique

Les délais servent à **protéger**, pas à sanctionner.

Silence médical (CRITIQUE)

Si :

- la sage-femme a reçu l'instruction
- a signalé un retard ou un obstacle
- **et qu'aucune réponse médicale n'arrive**

Le silence est automatiquement tracé :

- heure de la demande
- absence de réponse à T + X
- événement "silence médical"

Le silence devient un fait objectif, pas une zone grise.

9.5 Escalade automatique (V1)

Si une instruction :

- reste en retard
- ou bloquée sans réponse

ONEOBSTRA peut déclencher (selon paramétrage) :

- notification renforcée
- alerte au gynécologue de garde
- information hiérarchique clinique (optionnelle)

L'escalade est tracée, jamais implicite.

9.6 Exemple terrain (banalisé)

Situation

- CTG suspect
- Le gynécologue donne instruction :

“Surveiller étroitement, m’appeler si aggravation”

Dans ONEOBSTRA

1. Instruction ÉMISE (14:10)
2. REÇUE par la sage-femme (14:11)
3. EN COURS (surveillance)
4. Aggravation CTG
5. Alerte + appel médecin
6. Instruction RÉALISÉE (14:32)

Tout est clair, chronologique, défendable.

Intérêt médico-légal MAJEUR

Ce système permet de prouver :

- ce qui a été demandé
- quand
- par qui
- ce qui a été fait
- ce qui n’a pas pu l’être
- et pourquoi

Fin des instructions orales non traçables.

Règle officielle V1 (à afficher)

Toute instruction médicale doit être structurée, tracée et suivie dans le temps. Le retard, l’obstacle et le silence médical sont des états normaux documentés. Aucune instruction critique ne peut rester implicite.

Synthèse simple

- Le gynécologue instruit
 - La sage-femme exécute ou signale
 - Le temps est visible
 - Le silence est tracé
 - La timeline protège tous les acteurs
-

ANESTHÉSIE — PÉRIDURALE (V1 — VERSION COMPLÈTE ET OPPOSABLE)

Dans ONEOBSTRA V1, la péridurale est gérée comme un **processus médical sécurisé**, et **jamais comme un simple geste technique**.

Chaque étape est **explicite, horodatée, liée à un acteur identifié**, et **verrouillée techniquement** pour éviter toute dérive terrain.

10.1 Principe fondamental

La péridurale suit **obligatoirement** la chaîne suivante :

Demande

- Consentement valide
- Pré-anesthésie VALIDÉE
- Pose par anesthésiste
- Surveillance post-pose
- Incidents (si présents)

Aucune étape ne peut être sautée

Aucune étape n'est implicite

10.2 Demande de péridurale (OBLIGATOIREMENT TRACÉE)

Qui peut initier la demande ?

- Sage-femme (suite au souhait exprimé par la patiente)
- Gynécologue

La patiente ne crée pas elle-même la demande dans le système

La demande **ne vaut jamais autorisation**

Contenu de la demande (STRUCTURÉ — V1)

- Motif principal :
 - douleur importante
 - travail prolongé
 - indication médicale
- Niveau d'urgence :
 - non urgent

- urgent
- Contexte clinique résumé (menus)
- Destinataire :
 - anesthésiste

Événement timeline créé

Demande de péridurale

(auteur, date, heure, contexte)

10.3 Consentement — PRÉ-REQUIS ABSOLU

Règle V1

Sans consentement valide, il n'y a ni pré-anesthésie, ni péridurale.

Quand le consentement peut-il être recueilli ?

À l'admission (recommandé)

- patiente calme et lucide
- meilleure compréhension
- consentement anticipé

Au moment de l'acte (autorisé)

- patiente consciente et apte
- information donnée juste avant
- consentement tracé **avant la pose**

Après la pose : strictement interdit

Consentement implicite ou verbal non tracé : interdit

États possibles du consentement

- accepté
- refusé
- retiré (à tout moment)

Un consentement retiré bloque immédiatement toute anesthésie,
même si la pré-anesthésie était validée.

Événement timeline créé

Consentement anesthésie — accepté / refusé / retiré

10.4 Pré-anesthésie — OBLIGATOIRE, DISTINCTE, NON CONTOURNABLE

Règle NON NÉGOCIABLE V1

La péridurale ne vaut jamais pré-anesthésie. La pré-anesthésie est une évaluation médicale préalable obligatoire.

Qui réalise et valide la pré-anesthésie ?

Uniquement l'anesthésiste

- La sage-femme et le gynécologue peuvent **demander**
 - Ils ne peuvent **ni évaluer, ni valider**
-

Quand peut-elle être réalisée ?

- En amont de l'accouchement (idéal)
- À l'arrivée en clinique si absente
- En urgence (exception strictement tracée)

Jamais après la pose

Jamais rétroactivement

Contenu de la pré-anesthésie (STRUCTURÉ)

- évaluation des risques anesthésiques
- recherche de contre-indications
- vérification des examens requis
- vérification du consentement
- **décision médicale explicite :**
 - autorisation
 - refus
 - autorisation sous conditions

Événement timeline créé

Pré-anesthésie VALIDÉE / REFUSÉE

(auteur : anesthésiste, horodatage)

Statuts visibles dans l'UX

- VALIDÉE
- INCOMPLÈTE / EN ATTENTE

- ABSENTE / EXPIRÉE

Si ≠ VALIDÉE → pose BLOQUÉE

10.5 Pose de la péridurale

Conditions cumulatives OBLIGATOIRES

- consentement **valide**
- pré-anesthésie **VALIDÉE**
- acte réalisé par **un anesthésiste**

Aucun contournement possible

Aucun “oui verbal” accepté

Ce que fait l'anesthésiste

- réalise la pose
- indique le statut :
 - réussie
 - difficile
 - interrompue
- précise les conditions de pose

Événement timeline créé

Pose de péridurale

10.6 Surveillance post-pose (OBLIGATOIRE)

Début

- immédiatement après la pose
-

Surveillance MÈRE

- tension artérielle
 - fréquence cardiaque
 - douleur
 - motricité
 - sensibilité
 - tolérance générale
 - effets indésirables
-

Surveillance FŒTALE (si indiquée)

- CTG
- adaptation fœtale

Événements de surveillance

(horodatés, structurés)

10.7 Incidents anesthésiques (TOUJOURS TRACÉS)

Principe

Tout incident, même mineur, est un événement médico-légal.

Exemples

- hypotension
- échec de pose
- douleur persistante
- céphalées
- complication neurologique suspectée
- incident matériel

Événement timeline créé

Incident anesthésique

(actions, décisions, suites)

10.8 Cas particuliers — EXCEPTIONS STRICTES

Urgence vitale

Conditions cumulatives :

- danger vital immédiat
- patiente incapable de consentir
- décision médicale collégiale

Dans ONEOBSTRA :

- statut **URGENCE VITALE**
- justification structurée obligatoire
- traçabilité maximale

Exception rare, jamais implicite.

10.9 Verrous techniques ONEOBSTRA (V1)

- Bouton « poser péridurale » désactivé si :
 - consentement absent ou retiré
 - pré-anesthésie non validée
 - Validation rétroactive impossible
 - Pose par non-anesthésiste impossible
-

Intérêt médico-légal MAJEUR

ONEOBSTRA permet de prouver :

- qui a demandé
- quand le consentement a été donné
- qui a évalué le risque
- qui a validé
- qui a posé
- comment la surveillance a été assurée
- comment les incidents ont été gérés

Chaque responsabilité est clairement bornée.

RÈGLES OFFICIELLES V1 (À AFFICHER)

La péridurale suit un parcours strict et opposable : demande → consentement → pré-anesthésie validée → pose par anesthésiste → surveillance → incidents. Aucune étape ne peut être sautée dans ONEOBSTRA V1.

Synthèse ultra claire

- Demande ≠ autorisation
- Consentement indispensable
- Pré-anesthésie = décision médicale
- Pose réservée à l'anesthésiste
- Surveillance obligatoire
- Traçabilité totale

ONEOBSTRA transforme l'anesthésie en processus sécurisé, pas en pari terrain.

POST-NAISSANCE NÉONATAL

Continuité mère → bébé | Responsabilités claires | Timeline unique

11.1 Principe fondamental

Le nouveau-né est une section structurée du PatientCase maternel.

- Pas de dossier bébé indépendant (V1)
 - Aucune action néonatale avant la naissance
 - Continuité clinique et médico-légale totale
 - **Timeline unique mère → bébé**, lisible clinique & tribunal
-

11.2 Création du dossier néonatal

Qui ? La sage-femme

Quand ? Au moment exact de la naissance (voie basse **ou** césarienne)

Comment ?

1. La sage-femme valide l'événement **Naissance**
2. ONEOBSTRA crée automatiquement la **section Néonatal**
3. La timeline néonatale s'ouvre, rattachée au PatientCase

Événement :

Naissance — section néonatale créée

Aucune action néonatale possible avant cet événement.

11.3 Acteurs néonataux (V1)

Infirmière néonatale — responsable opérationnelle

- Réalise soins & surveillances
- Remonte anomalies
- Demande avis médicaux
- **Doit être explicitement affectée** (obligatoire)

Pédiatre — responsable médical

- Donne les instructions
- Interprète les analyses
- Prend les décisions

Visibles en temps réel par la sage-femme et le gynécologue.

11.4 Affectation & relais de l'infirmière néonat

Affectation initiale

- Par la **sage-femme**
- Immédiatement après la naissance

- Liste filtrée (infirmières en service)

Infirmière néonate affectée — Nom Prénom

Relais

- Fin de garde / indisponibilité
- Action **explicite**
- Historique conservé

Relais infirmière néonate — Nom1 → Nom2

Aucun soin néonatal sans infirmière affectée.

11.5 Soins infirmiers néonataux (STRUCTURÉS)

- Surveillance respiratoire
- Surveillance thermique
- Tonus / réactivité
- Alimentation initiale
- Soins courants

Règles UX

- Boutons = actes
- 1 clic = 1 événement
- Zéro texte libre critique
- Horodatage système

Surveillance néonatale — respiration normale

11.6 Instructions pédiatre → infirmière

- Instructions **structurées**
- Priorité (normale / urgente)
- Délai attendu
- Critères cliniques

Cycle

ÉMISE → REÇUE → EN COURS → RÉALISÉE
RETARD
OBSTACLE

Chaque transition = événement timeline.

11.7 Demandes infirmière → pédiatre

- Doute clinique
- Anomalie observée
- Aggravation
- Besoin d'avis

Demande d'avis pédiatre

Réponse ou silence

- Réponse → décision tracée
 - **Silence** → tracé automatiquement après délai
-

11.8 Accusés & délais

- Accusé de réception obligatoire pour instructions critiques
- Délais **paramétrables par clinique**
- Alertes & escalades automatiques

Les délais **protègent les soignants**.

11.9 Surveillance post-naissance immédiate

Paramètres (V1)

- Respiration
- Fréquence cardiaque
- Coloration
- Tonus
- Température
- Adaptation à la vie extra-utérine

Toute anomalie :

- Alerte
 - Visibilité pédiatre
 - Trace timeline mère → bébé
-

11.10 Analyses médicales néonatales

- Prescription : pédiatre (ou gynécologue si urgence)
 - Réalisation : infirmière
 - Résultats structurés
 - **Interprétation médicale obligatoire**
 - Alerte si non interprétée
-

11.11 Cas particulier — Césarienne

- Création du dossier néonatal **au moment de la naissance** au bloc
 - **Sage-femme** responsable de la création
 - Lieu tracé : *Bloc opératoire*
 - Surveillance néonatale **adaptée/renforcée**
 - Continuité mère ↔ bébé maintenue (même si séparation physique temporaire)
-

11.12 Visibilité & transparence

Visible en temps réel par :

- Sage-femme
- Gynécologue
- Pédiatre
- Anesthésiste (si concerné)

Plus aucun “je ne savais pas”.

Règle officielle V1

Le nouveau-né est intégré au PatientCase maternel. Tous les soins, instructions, demandes, réponses, délais et silences sont tracés dans une timeline unique, append-only et opposable.

Synthèse

- Bébé = section du PatientCase
- Infirmière agit (affectation obligatoire)
- Pédiatre décide
- Délais visibles, silences tracés
- Continuité mère → bébé garantie

ONEOBSTRA sécurise le post-naissance sans casser le terrain.

ANALYSES MÉDICALES NÉONATALES

Prescription encadrée | Lecture obligatoire | Zéro résultat orphelin

12.1 Principe fondamental

Aucune analyse médicale néonatale ne peut exister sans prescription, et aucun résultat ne peut rester sans interprétation médicale.

Dans ONEOBSTRA V1 :

- une analyse = **un acte médical structuré**
 - un résultat = **une responsabilité médicale**
 - le silence = **un événement tracé**
-

12.2 Prescription des analyses

Qui peut prescrire ?

- **Pédiatre**
- **Gynécologue** (notamment en contexte immédiat post-naissance ou d'urgence)

Infirmière : ne prescrit jamais

Prescription verbale non tracée : interdite

Contenu d'une prescription (STRUCTURÉ)

- type d'analyse :
 - glycémie
 - gaz du sang
 - bilirubine
 - hémoculture
 - autres (liste paramétrée V1)
- motif clinique (menu)
- urgence :
 - immédiate
 - standard
- délai attendu
- seuils de référence associés

Événement timeline créé

Analyse néonatale prescrite — Type

12.3 Réalisation des analyses

Qui réalise ?

L'infirmière néonatale

Conditions :

- infirmière **affectée** obligatoirement
 - prescription existante
 - acte tracé
-

Traçabilité de la réalisation

- date / heure de prélèvement
- type d'échantillon
- conditions particulières (menu)

Événement timeline créé

Analyse néonatale réalisée — Type

12.4 Résultats des analyses

Caractéristiques des résultats (V1)

- valeurs numériques structurées
- unités normalisées
- **seuils de référence visibles**
- indicateur automatique :
 - normal
 - limite
 - anormal

Le système **n'interprète pas médicalement**,
il met en visibilité le risque.

12.5 Interprétation médicale — OBLIGATOIRE

Principe V1 NON NÉGOCIABLE

Un résultat sans interprétation médicale est une non-prise en charge.

Qui interprète ?

- **Pédiatre (prioritaire)**
- **Gynécologue** (si prescripteur ou contexte particulier)

Infirmière : n'interprète jamais

Contenu de l'interprétation

- conclusion médicale :
 - normale
 - à surveiller
 - pathologique
- lien explicite avec les valeurs

- décision associée obligatoire

Événement timeline créé

Interprétation analyse néonatale — Conclusion

12.6 Décision médicale associée

Chaque interprétation **doit** déboucher sur une décision :

- poursuite de la surveillance
- traitement
- nouvel examen
- appel spécialisé
- transfert

Événement timeline créé

Décision médicale suite analyse néonatale

Analyse → interprétation → décision

Aucune chaîne incomplète acceptée.

12.7 Gestion du silence médical

Principe

Si une analyse est :

- réalisée
- avec résultat disponible
- **sans interprétation dans le délai attendu**

Alors ONEOBSTRA :

- déclenche une alerte
- trace le **silence médical**
- escalade selon règles

Événement :

Silence médical — analyse non interprétée

Le silence devient un fait objectif et opposable.

12.8 Délais & escalades

- délais paramétrables par :
 - type d'analyse

- niveau d'urgence
- escalade possible :
 - vers autre pédiatre
 - vers chef de garde

Objectif : **protéger le nouveau-né et les soignants.**

12.9 Visibilité & continuité mère → bébé

Les analyses néonatales sont visibles :

- dans la section Néonatal
- dans la timeline globale
- par :
 - sage-femme
 - infirmière néonate
 - pédiatre
 - gynécologue

Pas de silo, pas d'oubli.

Règles officielles V1 (à afficher)

Toute analyse néonatale doit être prescrite, réalisée, interprétée et suivie d'une décision médicale. Aucun résultat ne peut rester sans lecture médicale. Les silences sont tracés et opposables.

Synthèse ultra claire

- Analyse = prescription médicale
- Infirmière réalise
- Médecin interprète
- Seuils visibles
- Décision obligatoire
- Silence tracé

ONEOBSTRA transforme les analyses néonatales en chaîne de responsabilité complète.

ALERTES & ESCALADE

Sécurité clinique | Responsabilités claires | Zéro alerte décorative

Dans ONEOBSTRA V1, une alerte **n'est jamais un simple signal visuel.**

C'est un **fait médico-légal**, horodaté, attribué et **opposable.**

Toute alerte implique :

- un **déclencheur objectif**
 - un **destinataire identifié**
 - un **délai de réponse**
 - une **traçabilité de la réponse... ou du silence**
-

13.1 Principe fondamental

Une alerte ONEOBSTRA correspond à une situation clinique ou organisationnelle qui nécessite une action, une décision ou une justification.

- Pas d’alertes “pour info”
 - Pas d’alertes sans responsable
 - Pas d’alertes non tracées
 - Alertes **actionnables, suivies et opposables**
-

13.2 Déclencheurs d’alerte (V1)

Les alertes sont déclenchées automatiquement ou manuellement à partir de faits tracés.

Déclencheurs cliniques

- paramètres hors seuil (mère ou bébé)
 - anomalie CTG
 - dégradation clinique
 - incident anesthésique
-

Déclencheurs organisationnels

- instruction non exécutée
 - instruction en **retard**
 - instruction marquée **obstacle**
 - absence d’accusé de réception
-

Déclencheurs biologiques

- analyse réalisée sans interprétation
 - analyse avec valeur hors seuil
 - délai d’interprétation dépassé
-

Déclencheur critique : silence médical

- demande sans réponse
- instruction sans retour
- analyse non interprétée dans le délai

Le silence est **un événement**, pas une absence d'événement.

13.3 Types d'alertes (V1)

Chaque alerte a un **type explicite** :

- Clinique
 - Retard
 - Urgence
 - Biologique
 - Silence médical
 - Médico-légal
-

13.4 Destinataires des alertes

Selon le type, une alerte est adressée à :

- sage-femme en charge
- gynécologue référent
- anesthésiste
- pédiatre
- chef de garde (si escalade)
- responsable clinique (optionnel)

Toujours au bon rôle, jamais “à tout le monde”.

13.5 Cycle de vie d'une alerte

DÉCLENCHÉE
→REÇUE
→PRISE EN COMPTE
→RÉSOLUE
ESCALADÉE

Chaque étape :

- est horodatée
- est signée par rôle
- crée un événement timeline

13.6 Délais & règles d'escalade

Délais

- paramétrables par :
 - type d'alerte
 - urgence
 - clinique

Escalade automatique

Si le délai est dépassé :

1. rappel au destinataire initial
2. notification au niveau supérieur
3. traçabilité du dépassement

Événement :

Alerte escaladée — délai dépassé

13.7 Alerte manuelle (V1)

Qui peut déclencher ?

- sage-femme
- infirmière néonate
- médecin

Quand ?

- doute clinique
- situation atypique
- sentiment de non-sécurité

Le doute est un motif valide.

Événement :

Alerte manuelle déclenchée

13.8 Verrous anti-fatigue (V1)

ONEOBSTRA applique un **silence intelligent** :

- pas de doublons inutiles
- regroupement contextuel

- persistance tant que non résolue

Moins d’alertes, mais toutes sérieuses.

13.9 Visibilité & traçabilité

Chaque alerte est visible :

- dans la timeline
- dans la vue supervision
- dans la vue tribunal

Contient :

- déclencheur précis
 - acteur concerné
 - délais
 - réponses ou silences
 - escalades
-

Intérêt médico-légal MAJEUR

ONEOBSTRA permet de prouver :

- qu’une alerte a existé
- quand elle a été reçue
- qui devait répondre
- ce qui a été fait
- ou qu’un **silence** a eu lieu

L’absence d’action devient un fait documenté.

Règles officielles V1 (à afficher)

Toute alerte ONEOBSTRA correspond à une obligation de prise en compte. Les réponses, retards, escalades et silences sont tracés et opposables. Aucune alerte n’est décorative.

Synthèse ultra claire

- Alerte = responsabilité
- Délais paramétrables
- Silences tracés
- Escalade automatique

- Timeline opposable

ONEOBSTRA transforme les alertes en preuve, pas en bruit.

PARAMÉTRAGE V1

Paramétrable :

- Par clinique
- Actes activés
- Seuils
- Délais
- Alertes
- Modèles PDF
- Accès par rôle

Non paramétrable :

- Logique métier
 - Rôles
 - Cycle PatientCase
 - Timeline
-

UX — RÈGLES NON NÉGOCIABLES

- En-tête fixe
 - Codes couleur métier
 - Pas de texte libre critique
 - Vue clinique $\neq$ vue tribunal
 - Zéro ambiguïté
-

MÉDICO-LÉGAL & AUDIT

- Journal des accès
 - Journal des exports
 - Timeline opposable
 - Exports PDF
 - Conformité RGPD
-

ARCHITECTURE TECHNIQUE

- Django
- Apps modulaires

- Services métier
 - Timeline centrale
 - RBAC contextuel
 - Tests métier
-

MAINTENANCE V1

Autorisé :

- Bugs
- Performance
- Sécurité
- UX (sans règle)

Interdit :

- Nouvelles règles métier
 - Nouveaux rôles
 - Nouveaux parcours
-

CONCLUSION OFFICIELLE

ONEOBSTRA V1 est complète, cohérente, figée et prête à être codée, déployée et auditée.